

Druga strona checking — *unikanie wzmacnia lęk*

Luźne ubrania, brak luster, brak fotografii, brak basenu. Mechanizm jak w fobii: unikanie → lęk się wzmacnia → utrzymuje „groźność” ciała.

CZAS: 30 min identyfikacji + miesiące ekspozycji **REALIZACJA:** faza 2 CBT-E, równoległe z checking

ŹRÓDŁO: Rosen (1996, *body image therapy*); Fairburn (2008, rozdz. 8); Vocks i in. (2007); Hildebrandt i in. (2012, mirror exposure)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **typowe formy unikania** (ubrania, lustra, fotografie, kontakt fizyczny, basen) + mechanizm pętli unikania. Sekcja 02 — **siedem kroków ekspozycji stopniowej**. Sekcja 03 — **moja hierarchia ekspozycji** z oceną SUDS.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Body avoidance — chroniczne unikanie konfrontacji z własnym ciałem: luźne ubrania ukrywające kształt, brak luster w domu (lub zasłonięte), zakaz fotografowania, unikanie basenu i plaży, unikanie kontaktu fizycznego (przytulanie, intymność), unikanie ważenia (przeciwieństwo checking). Rosen (1996): unikanie jest *drugą stroną* nadwartościowania — równie potężny mechanizm utrzymujący jak checking. Pętla analogiczna do fobii: unikanie → lęk się wzmacnia → utrzymuje „groźność” ciała → pacjent *nigdy* nie ma okazji się przekonać, że ciało nie jest niebezpieczne. Rozwiązanie identyczne jak w terapii fobii — *stopniowa ekspozycja*.

01 Typowe formy body avoidance

FORMA	JAK SIĘ MANIFESTUJE
<i>Ubrania</i>	Luźne, workowate, ukrywające kształt. Często warstwowo — nawet w upale. Unikanie obcisłych ubrań, krótkich rękawów, dekolatów, sukienek. Zakup ubrań o numer/dwa za duże.
<i>Lustra i odbicia</i>	Brak luster w domu lub zasłonięte. Unikanie wystaw sklepowych, drzwi balkonowych, witryn. Bardziej drastyczne: brak luster nawet w łazience (mycie się „na ślepo”).
<i>Fotografie</i>	Zakaz fotografowania, unikanie selfie, brak zdjęć z rodzinnych okazji. Usuwanie istniejących zdjęć. „Nie mam żadnych zdjęć z ostatnich 5 lat” — typowa skarga rodziny.
<i>Basen, plaża, sauna</i>	Unikanie miejsc wymagających częściowego rozebrania. Rezygnacja z wakacji nad morzem, rodzinnych wyjazdów. Strój kąpielowy zostaje „na nigdy”.
<i>Kontakt fizyczny</i>	Unikanie przytulania, intymności, dotyku. Lęk, że ktoś „poczucie” ciała. Konsekwencje dla relacji: dystans z partnerem, brakujące doświadczenie bliskości.

Pętla unikania = pętla fobii. Unikanie → lęk się wzmacnia → utrzymuje „groźność” ciała. Bez ekspozycji pacjent nigdy nie ma okazji przekonać się, że ciało nie wymaga ukrywania.

1. **Psychoedukacja** — „Unikanie ciała wydaje się chronić przed cierpieniem. W rzeczywistości wzmacnia lęk i utrwała wstyd. To pętla fobii — bez ekspozycji się nie wyleczysz”.
2. **Identyfikacja** — pacjent wypisuje wszystkie formy unikania: ubrania, lustra, fotografie, miejsca, sytuacje społeczne. Lista zwykle 15–25 pozycji.
3. **Ocena SUDS** — dla każdej formy lęk 0–10. „Jakie SUDS gdyby teraz zdjąć workową bluzę?” „SUDS gdyby spojrzeć w lustro w białiznie?”
4. **Hierarchia** — uporządkuj od najniższego do najwyższego SUDS. Zaczynaj od „3–5” (np. „nosić obcisłą bluzkę pod swetrem”), nie od „9–10” (np. „iść na basen”).
5. **Ekspozycja — konkretny plan** — co, kiedy, gdzie, jak długo. Np. „czwartek 14:00, dom, noszę obcisłą koszulkę przez 2h”. Wcześniej: SUDS przewidywane. Po: SUDS rzeczywiste.
6. **Powtarzanie** — każda ekspozycja 5–8 razy zanim przejście do następnej. SUDS spada zwykle z 5 → 2 po 5 powtórzeniach. Habitacja.
7. **Specjalny protokół: mirror exposure** — patrz osobna karta. Najsilniejsza interwencja, wymaga osobnego protokołu (15–30 min, opis bez oceny, 6–12 sesji, RCT-skuteczne).

LP.	FORMA EKSPOZYCJI (KONKRETNIE)	SUDS 0–10	PLAN (DATA, MIEJSCE)
1			
2			
3			
4			
5			

Klucz: body avoidance i body checking są dwiema stronami tego samego mechanizmu — nadwartościowania ciała. Pacjent może mieć oba *jednocześnie*: obsesyjnie sprawdzać i unikać. Praca równoległa, nie sekwencyjna. Mirror exposure (osobna karta) — najsilniejsza interwencja dla body avoidance, RCT-skuteczna (Hildebrandt i in., 2012; Vocks i in., 2007). **Komunikat dla pacjenta:** „ukrywanie ciała nie chroni Cię — zamyka. Im dłużej unikasz, tym mocniej ciało staje się „groźne”. Ekspozycja zwraca Ci wolność wyboru, co nosisz, gdzie idziesz, kogo dotykasz”.

⚠ **Ekspozycja u pacjentów z bardzo niską masą:** u pacjentów w stanie skrajnego wyniszczenia (BMI <14) ekspozycja na ciało może wywoływać silny dyskomfort związany z realnymi objawami (obojczyki, żebra, kości biodrowe). Praca z ekspozycją równoległa do rehabilitacji żywieniowej — nie jako wymóg „zaakceptowania” wyniszczenia, lecz jako proces budowania nowej relacji z ciałem w trakcie restauracji wagi.